

如果尿毒症免疫反应低下,是否意味着对同种移植肾的排斥反应可能较低。为此,目前正在对有所期待尸体肾移植患者作前瞻性研究,以测定由 PHA 和混合同种细胞刺激的淋巴细胞 DNA 的合成能力。

(王毓明摘译 诸荣思校)

0128 慢性肾功能衰竭时的血清反 T_3 (3,3',5'-L-三碘甲腺原氨酸) [J Kosowicz et al: Nephron 26:85, 1980 (英文)]

三碘甲腺原氨酸(T_3)与反 T_3 (reverse T_3)在周围组织特别是肝脏与肾脏中引起代谢。 T_3 与反 T_3 经单脱碘产生3,3'-二甲腺原氨酸和3,5'-二甲腺原氨酸,这两种物质与未代谢的 T_3 及反 T_3 一起从尿中排出。在肝脏, T_3 及反 T_3 和硫酸盐及葡萄糖醛酸结合,随胆汁分泌至肠道,从粪便排出。在许多情况下,如肝硬化、心肌梗塞、饥饿时,血清 T_3 降低而反 T_3 升高。这说明 T_4 代谢由活性(T_3)向失活(反 T_3)转化。

作者测定了40例晚期肾功能衰竭(慢性肾衰)患者血清总 T_3 、 T_4 和 TSH 浓度,特别是反 T_3 浓度,来判断甲状腺机能。另以47名健康人与42例未经治疗的原发性甲状腺机能减退患者的测定结果作对照。

发现:约 $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$ 的晚期慢性肾衰患者,血清 T_3 低于正常,个别甚至低达原发性甲状腺机能减退水平,而血清反 T_3 则大部分(31例)正常,但有9例升高,这可能由于低蛋白饮食、晚期病人全身情况差,以及慢性肾盂肾炎加重之故。所有甲状腺机能减退患者,血清反 T_3 浓度全部低于正常,与尿毒症患者无交叉现象。两者血清 TSH 也有显著区别,慢性肾衰患者 TSH 正常,而原发性甲减患者明显升高。作者认为测定血清反 T_3 与 TSH 可以鉴别慢性肾衰和原发性甲减。

慢性肾衰患者反 T_3 正常或稍高,而 T_3 、 T_4 减少,表明 T_4 外周代谢显著紊乱。作者通过计算 T_3/T_4 ,反 T_3/T_4 和反 T_3/T_3 克分子血清浓度之比,比较慢性肾衰患者和正常人的结果。发现慢性肾衰者,反 T_3/T_4 比例明显增高。认为这可能因反 T_3 的代谢清除减少或 T_4 转化为 T_3 的外周代谢增加之故。在原发性甲减患者 T_3/T_4 比例升高,说明这些患者 T_4 转化为 T_3 增加。

慢性肾衰患者血清 T_3 和 T_4 水平低而 TSH 保持正常,说明对甲状腺激素低水平,下丘脑垂体轴敏感性降低,和/或在下丘脑 TRH 刺激垂体,丧失分泌

TSH 的能力。

作者认为:慢性肾衰血清 T_3 降低,反 T_3 正或升高, TSH 正常。这有别于原发性甲减(反 T_3 、 T_3 、 T_4 降低, TSH 升高),与继发性甲减(反 T_3 、 T_3 、 T_4 和 TSH 均低)。尿毒症与营养不良均见 T_3 降低, TSH 正常,但营养不良患者反 T_3 常升高2倍,尿毒症则正常或轻度升高,可资鉴别。

(王毓明摘译 金权屑校)

0129 苯氧苄胺(phenoxybenzamine)和 α -甲基多巴药物相互作用所致的尿失禁 [Peter G et al: CMAJ 124(2):174, 1981 (英文)]

使用苯氧苄胺、甲基多巴、利血平及氯丙嗪,引起压迫性尿失禁,在文献中已经有过报告。然而,以前从未报道过,因苯氧苄胺及甲基多巴药物相互作用所致之完全尿失禁。

病例报告:

患者,女,50岁,不吸烟,因雷诺氏病,曾行双侧腰交感神经阻断术,结果双腿局部缺血症状减轻,而无术后泌尿道症状。虽然患者自诉,自妊娠中毒症后发生的高血压,已有18年,而目前血压在正常范围内,未服降压药物。类风湿因子、红斑性狼疮细胞、抗核抗体及冷球蛋白试验结果,反复阴性。血清免疫球蛋白水平正常,蛋白电泳亦正常,反映了该疾病的最初状况。

随后,患者的指端血管痉挛状况恶化,开始用苯氧苄胺,经过6个月治疗,无多大改善。当卧位测量血压时,收缩压和舒张压均增高,以后,服用 α -甲基多巴,以降低血压和解除血管痉挛。然而,当两种药物同时应用时,尽管会阴完全保持良好感觉,24小时内,出现完全尿失禁,患者决定停服苯氧苄胺,但仍然服用 α -甲基多巴,小便则可完全控制。2个月后,患者两手的某些手指,出现坏疽前的损害,为避免另一次交感神经切除术,患者重新开始服用苯氧苄胺,又导致完全尿失禁。

讨 论

膀胱是受 α -肾上腺素能和胆碱能植物神经纤维支配的,而尿道内括约肌主要是由后者支配的,膀胱颈的正常紧张度取决于交感神经的紧张度。双侧交感神经切除术,可降低尿道压力,造成尿失禁。苯氧苄胺为 α -肾上腺素阻断剂,曾用于改善神经性引起的膀胱口阻塞。 α -甲基多巴降低了来自中枢神经系统之交感能的释放。也由于产生了 α -甲基去甲肾上腺

素、即假性神经传递介质、降低了周围交感神经的活性。

行双侧交感神经切除术及只用一种药物时的联合作用本文患者并未引起尿失禁。而两种药物同时应用时,却导致完全尿失禁,而不丧失会阴感觉。大概是两种药物之协同抗交感神经的活动通过交感神经切除术而得到加强。然而, α -甲基多巴通过它的中枢作用,也起了一定的作用。

苯氧苄胺和 α -甲基多巴之间的相互作用,可用于治疗先天的或后天的神经性所致的膀胱口阻塞,以及用于下尿道手术后引起的尿道阻塞。

(李成建译 袁政汉校)

0130 肾包膜下血肿:诊断和治疗的一个难题 [Mark J et al: J Urol 125 (2):157, 1981 (英文)]

本文作者报告了14例高血压患者罹患了肾包膜下血肿,其年龄为17至66岁,平均年龄35.8岁,肾包膜下血肿左侧6例,右侧8例,两侧发病率几乎相等。男性12例,女性2例,差不多近均有高血压或原有高血压加剧。11例有腰痛,3例有肉眼血尿并能触及腰部有肿块。8例有肾外伤史如肾穿刺活检等作为诱因,1例给了抗凝治疗,1例抗凝治疗剂量过量,1例为肾肿瘤,4例为特发性无诱因可查。11例有慢性创伤性高血压大多数经肾切除术而改善了病情或治愈(7例),其余病例用去除血肿或部分肾切除术而得到改善(4例中有2例)。3例急性肾包膜下血肿有典型的临床和X线表现,其中1例病情稳定,诊断肯定,保守治疗其余两例急性肾包膜下血肿由于不能承担手术而采取非手术处理也是有效的,3例高血压后来得到缓解,血肿吸收。肾血管造影,被认为可以对所有肾包膜下血肿作出诊断静脉肾盂造影,使大多数病例均可发现(13/14),肾扫描和肾超声波检查对诊断的帮助不大,3例曾用CT(电子计算机体层扫描)均得到正确的诊断,1例对病侧肾静脉测定了肾素。在大多数肾包膜下血肿是能得到满意的治疗。

1939年Page曾报导赛璐玢诱发纤维性肾周炎,压迫肾实质使局部缺血,因而引起全升高血压的一种发病机制。Page认为肾包膜下血肿引起肾局部受压缺血而并发全身性高血压,此称为Page氏肾(Page Kidney)。肾包膜下血肿与肾周围血肿在解剖学和放射学上是各不相同的,肾包膜下血肿位于肾实质和包膜之间,肾周围血肿是在包膜和肾周(Gerota's)筋

膜之间,两者预后各不相同,本文作者认为腹部肾输尿管膀胱平片,IVP,肾动脉造影,CT对肾包膜下血肿和肾周围血肿具有重要鉴别诊断价值。

(陈衍思 杨俊霞摘 陈文彩校)

0131 体外冲击波粉碎肾结石 [C Chaussy et al: Lancet I (8207):1265, 1980 (英文)]

多年来,人们在不断探索各种治疗肾结石的方法,但手术摘除仍为上选之法。肾结石化学疗法仅限于尿酸结石;物理疗法如超声波碎石或电动液压波(electrohydraulic)碎石,只适用于下尿路结石,这些物理疗法需要能源和结石之间直接接触。

作者在六年中,实验动物身上研制出一种无损害的、非接触性击碎肾结石的方法。其原理是将体外产生的冲击波集中在肾结石或靶子上。冲击波是由一个水下高压电容火花放电持续百万分之一秒产生的,火花电极置于一椭圆形反射容器的一个焦点上。电容器高压放电引起水爆发性汽化。由于它的突然膨胀,产生冲击波。冲击波源位于椭圆形反射器的焦点上,所产生的全部能量从四周壁反射,并再次聚集到第二个焦点上,故第二个焦点是能量最高密集点,结石或靶子就放置在此。由于机体绝大部分组织的声阻抗接近水的声阻抗,所以冲击波可均匀地传过机体。当冲击波到达结石时,它被部分地反射。因为声阻抗的突然改变,故进入结石的那部分冲击波即被吸收。这就产生压力梯度,形成分力和剪力,最后击碎固体物质。贯穿入的冲击波之另一部分在结石的对侧,即结石内面再被反射回来,在这里再次发生相变,产生剪力和分力,破坏另一部分。

体外研究证明,不同化学成分的结石如适当地放在靶心,均能被冲击波击碎。通过检查红细胞及对承受冲击波的淋巴细胞培养,研究周围组织可能受到的损伤。溶血非常轻微,但随着承受冲击波次数的增加,溶血也有所加重。在混合淋巴细胞培养中,细胞计数无明显变化。由丝裂原(mitogen)(植物血凝素),或由淋巴细胞衍生(LD)-各种经照射的反应细胞的增殖率亦无明显降低。此外,冲击波对已麻醉小鼠的腹部,在24小时后或二周后并未引起病理改变。但对实验动物胸部的作用可引起广泛、致命的肺组织损伤。这可能是肺组织和水之间声阻抗明显不同,使肺组织吸收大量波能所致。如应用“斯太洛”泡沫塑料(Styropore)(一种空气调节的塑料制品)保护胸部可以避免肺损伤。

结果,所治疗的60只狗中,96%结石被冲击波击